



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 08-09-2024 7:41:02

Página 1 de 2

Información Paciente

			N° Epicrisis	
			413012	
Nombre	: Mario Enrique Trincado Montecinos	Rut	: 6.556.422-K	N° Archivo : 2224942
Edad	: 72a 3m 1d	Fecha Nacto:	: 07/06/1952	Sexo : Masculino
Dirección	: P/El Lilen 14052 V/ J Alessandri	Comuna	: Puente Alto	Teléfono : 9 7587 6043

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso	: 23/08/2024	07:13	Días Estadía: 16
Unidad de Egreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso	: 08/09/2024	07:09	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Sepsis Foco Abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

AM: ERC etapa IV-V, no dialítica, HTA, cancer de colon.

AQx: cirugía de control de daño abdominal por apuñalamientos múltiples, reparación de hernias. Reseccion de colon + colostomia terminal en marzo 2023 por cancer de colon transverso.

Fármacos: furosemida, atenolol, alopurinol, bicarbonato, ácido fólico. No recuerda dosis de fármacos.

Alergias: No refiere

Hábitos : Tabaquismo desde los 9 hasta los 60 años, 1 cajetilla al día, en días de más consumo hasta 3 cajetillas diarias. OH suspendido hace 10 años, consumo de hasta 4 botellas de vino + 4 cervezas al día cuando tenía consumo activo.

Paciente con antecedentes descritos, ingresa electivamente el 23/08 para realizacion de reconstitucion de transito intestinal. Cirugia sin incidentes, con enteroanastomosis latero-lateral y cierre de colostomia (Laparotomia LMSIU + colectomia derecha + reseccion nodulo mesenterico obs granuloma + reseccion yeyuno 30cm + enteroenteranastomosis L-L mecanica tipo barcelona + reseccion colon descendente y angulo esplenico + ileosigmoidoanastomosis L-L mecanica tipo barcelona. + herniorrafia ostomal + cierre pared con malla vycril).

Paciente post pabellon queda en recuperacion donde evoluciona inicialmente bien, inciando alimentacion con regimen liquido , con HDN autosostenida. Desde la mañana del 25/08 se describe paciente con mayor compromiso del estado general, con tendencia a la hipotension, nauseoso, con mala perfusion distal . Evaluado por anestesista se objetiva paciente hipotenso, mal perfundido, por lo que se reanima con volumen e inician DVA. Se solicita evaluacion por coordinador de UCI y se indica traslado a esta unidad. Previamente paciente se intuba y conecta a VMI por mayor compromiso del sensorio y hemodinamico. Se describe presencia de contenido alimentario en hipofaringe al momento de la intubacion. Se traslada a UCI previo paso por scanner. Ingres a en malas condiciones generales, con apoyo de NAD a 0.3 mcg/kg/min, con FIO2 40% en modo AC por volumen.

Diagnosticos de Ingreso a UCI:

1.- Shock septico foco abdominal vs pulmonar

- Neumonia aspirativa

- Antecedentes de reconstitucion de transito intestinal 23/08/24

2.- Antecedentes

Evolución por sistemas

Fecha Epicrisis : 08/09/2024 07:41

Página 1 de 2

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 08-09-2024 7:41:02

Página 2 de 2

- 1) HDn y CV: paciente evoluciona de manera desfavorable, con req de DVA al alza, los cuales empeoran el 05/08 en contexto de 2do hit infeccioso intrahospitalario.
- 2) Vent: Sin lograr destete, con mala respuesta a modalidades P A/AC por lo que se mantiene en V A/C durante hospitalización
- 3) En priemra instancia con esquema de primera linea para foco abdominal, el cual se rota a imipenem - vancomicina ante mala respuesta por 5 días. Se agrega cobertura antifúngica sin resultado
- 4) Renal e HD: mala tolerancia a diálisis, con hipotensión marcada. Oligoanúrico mantenido
- 5) Nutri: se intenta nutrir por NPTC, con mala respuesta, dado alza de BUN y alteraciones ELP.

Ante evolución desfavorable, se establece techo terapéutico el día 07/09 en conjunto con jefatura de modulo. paciente fallece el 08/09 a las 06:40. Se extiende certificado de defunción

Diagnóstico de Egreso

Sepsis -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece 06:40 del 08/09. Se extiende certificado de defunción. se trata de contactar a familiares

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Hans Clausdorff Fiedler
Médico Tratante (Staff)